INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA

Protocolo Institucional

PRIORIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PARA CASOS CRÍTICOS

2026

Av. João Machado Nº 1234 . Centro
João Pessoa . Paraíba
CEP: 58013 522
T. 83 2107 9500
www.hsvp-iwgp.com.br
iwgp90@hotmail.com

CNPJ: 09124165000140

1. INTRODUÇÃO

A priorização do atendimento aos casos críticos hospitalares constitui uma estratégia essencial para a segurança do paciente, permitindo o reconhecimento precoce de situações de risco, o direcionamento adequado dos recursos assistenciais e a redução de atrasos na avaliação e na intervenção clínica.

Este protocolo estabelece critérios para identificar pacientes em estado crítico ou com sinais de deterioração clínica, definir prioridades de atendimento, acionar as equipes responsáveis e garantir a continuidade segura da assistência.

A priorização deverá considerar a gravidade clínica, o risco iminente à vida, a possibilidade de deterioração rápida e a necessidade de intervenção imediata, não devendo ser determinada exclusivamente pela ordem de chegada, pelo setor de internação ou pela disponibilidade momentânea de profissionais.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Padronizar os critérios de priorização e o fluxo de atendimento aos casos críticos, garantindo resposta oportuna, comunicação efetiva e assistência segura.

2.2 Objetivos específicos

- Reconhecer precocemente sinais de gravidade e deterioração clínica.
- Estabelecer níveis de prioridade assistencial.
- Definir critérios de acionamento das equipes médicas e multiprofissionais.
- Padronizar a comunicação entre os profissionais.
- Reduzir atrasos no atendimento às emergências.
- Orientar o registro, a notificação e o monitoramento das ocorrências.
- Promover a análise dos resultados e a melhoria contínua dos processos assistenciais.

3. ABRANGÊNCIA

Aplica-se às equipes assistenciais e aos setores hospitalares envolvidos no cuidado ao paciente, incluindo unidades de internação, pronto atendimento, Unidade

de Terapia Intensiva (UTI), centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica, unidades de diagnóstico e demais áreas assistenciais, conforme a estrutura institucional.

4. DEFINIÇÕES

Caso crítico: situação clínica que apresenta ameaça imediata à vida ou risco elevado de deterioração, exigindo intervenção urgente.

Deterioração clínica: agravamento do estado do paciente identificado por alterações dos sinais vitais, do nível de consciência, da respiração, da circulação ou por outros sinais de alerta.

Priorização assistencial: classificação da urgência de atendimento conforme a gravidade e o risco clínico.

Equipe de resposta rápida: equipe designada pela instituição para avaliar e intervir diante de critérios definidos de deterioração clínica.

Escalonamento assistencial: comunicação e acionamento progressivo de profissionais e recursos de maior complexidade quando a situação exigir.

5. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO

A prioridade deverá ser definida a partir da avaliação clínica, dos sinais vitais, da condição geral do paciente e dos protocolos específicos aplicáveis.

Prioridade	Classificação	Conduta esperada
P1 – Imediata	Emergência com risco iminente à vida	Acionar imediatamente o código de emergência institucional e iniciar as medidas de suporte previstas nos protocolos.
P2 – Muito urgente	Instabilidade clínica importante ou deterioração significativa, sem parada cardiorrespiratória no momento	Acionar imediatamente o médico responsável e/ou a equipe de resposta rápida, conforme o fluxo institucional.
P3 – Urgente	Alteração clínica relevante, sem sinais atuais de ameaça iminente à vida	Solicitar avaliação clínica prioritária, monitorar e reavaliar conforme a gravidade.
P4 – Programada ou de rotina	Paciente estável, sem sinais de deterioração aguda	Manter o atendimento conforme a programação assistencial e as necessidades identificadas.

Importante: os níveis acima constituem uma proposta de organização interna e não substituem a classificação de risco específica do pronto atendimento, quando aplicável. A instituição deverá definir os tempos máximos de resposta de cada nível após avaliação da capacidade operacional.

6. SINAIS DE ALERTA E CRITÉRIOS PARA ACIONAMENTO

6.1 Emergência imediata – P1

São exemplos de situações que exigem acionamento imediato do fluxo de emergência:

- Parada cardiorrespiratória ou ausência de sinais de circulação.
- Obstrução grave de vias aéreas.
- Insuficiência respiratória aguda grave.
- Choque ou sinais de hipoperfusão importante.
- Rebaixamento súbito e importante do nível de consciência.
- Convulsão prolongada ou repetida sem recuperação adequada.
- Hemorragia importante com instabilidade clínica.
- Anafilaxia com comprometimento respiratório ou circulatório.

6.2 Deterioração clínica importante – P2

São exemplos de situações que exigem avaliação imediata e escalonamento:

- Queda importante da saturação de oxigênio ou aumento da necessidade de oxigênio.
- Hipotensão importante ou queda significativa da pressão arterial em relação ao padrão do paciente.
- Taquicardia ou bradicardia acentuada associada a sintomas ou instabilidade.
- Alteração aguda do estado mental ou confusão de início recente.
- Dor torácica sugestiva de síndrome coronariana aguda.
- Suspeita de sepse com sinais de disfunção orgânica.
- Piora clínica rápida, mesmo quando os parâmetros isolados não atingem os limites definidos.

Os limites numéricos para frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação, temperatura e nível de consciência deverão ser definidos no anexo institucional de alerta precoce (News), considerando o perfil dos pacientes, as condições clínicas específicas e os protocolos adotados.

A ausência de alteração numérica isolada não exclui gravidade. A preocupação fundamentada da equipe, do paciente ou do acompanhante deverá ser considerada na decisão de escalonamento.

7. FLUXO DE ATENDIMENTO AOS CASOS CRÍTICOS

Etapa 1 – Identificação

Qualquer profissional que identifique sinais de gravidade deverá comunicar imediatamente a equipe assistencial responsável.

Etapa 2 – Avaliação inicial

A equipe habilitada deverá avaliar a condição clínica, verificar os sinais vitais e reconhecer a necessidade de intervenção imediata, respeitando suas competências profissionais.

Etapa 3 – Acionamento

P1: acionar imediatamente o código de emergência institucional.

P2: acionar imediatamente o médico responsável e/ou a equipe de resposta rápida.

P3: solicitar avaliação clínica prioritária e estabelecer monitoramento.

P4: manter o fluxo assistencial programado, com reavaliação quando indicada.

Se não houver resposta no tempo estabelecido pela instituição, o profissional deverá escalar a solicitação à liderança assistencial e ao próximo nível de resposta previsto.

Etapa 4 – Intervenção e estabilização

Iniciar as medidas de suporte previstas nos protocolos específicos, disponibilizar equipamentos e materiais necessários e garantir acompanhamento contínuo conforme a gravidade.

Etapa 5 – Definição do local de cuidado

Após avaliação clínica, definir a necessidade de manutenção no setor, monitoramento intensificado, transferência para unidade de maior complexidade ou encaminhamento a outro serviço, conforme indicação clínica e disponibilidade segura de recursos.

Etapa 6 – Comunicação e passagem do caso

Transmitir as informações essenciais de forma estruturada, utilizando o método institucional de comunicação, preferencialmente SBAR (Situação, Breve histórico, Avaliação e Recomendação).

Etapa 7 – Registro e continuidade assistencial

Registrar a identificação da intercorrência, os horários, os sinais clínicos, os profissionais acionados, as intervenções realizadas, as respostas obtidas e o desfecho.

8. RESPONSABILIDADES

8.1 Equipe de enfermagem

- Reconhecer sinais de alerta e comunicar imediatamente as alterações.
- Realizar avaliação e monitoramento conforme suas competências.
- Acionar os fluxos estabelecidos sem atrasar o atendimento.
- Registrar os cuidados e as comunicações realizadas.
- Garantir a continuidade da assistência e a passagem segura das informações.

8.2 Equipe médica

- Avaliar o paciente conforme a prioridade clínica.
- Instituir as condutas diagnósticas e terapêuticas indicadas.
- Definir a necessidade de transferência ou suporte de maior complexidade.
- Registrar a avaliação, as decisões e o plano de cuidados.

8.3 Lideranças assistenciais

- Assegurar o cumprimento do protocolo.
- Facilitar o acionamento das equipes e dos recursos necessários.
- Intervir diante de atrasos ou falhas no fluxo.
- Comunicar situações críticas à gestão, quando pertinente.

8.4 Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)

- Monitorar incidentes relacionados a atrasos ou falhas no atendimento.
- Apoiar a análise de eventos adversos e fatores contribuintes.
- Propor medidas preventivas e acompanhar os planos de ação.
- Contribuir para capacitações e monitoramento dos indicadores.

8.5 Direção hospitalar

- Garantir condições estruturais e recursos necessários.
- Aprovar e divulgar o protocolo.
- Definir os responsáveis, os códigos de emergência e os tempos institucionais de resposta.
- Acompanhar os resultados e promover melhorias.

9. COMUNICAÇÃO E REGISTRO

Toda intercorrência crítica deverá ser documentada no prontuário e comunicada aos responsáveis conforme o fluxo institucional.

O registro deverá conter, quando aplicável:

- Data e horário da identificação.
- Sinais clínicos e alterações observadas.
- Classificação de prioridade atribuída.
- Horário e profissional acionado.
- Horário da avaliação e das intervenções.
- Evolução clínica e resposta às medidas adotadas.
- Decisão sobre transferência ou continuidade do cuidado.
- Identificação dos profissionais envolvidos.

Os registros deverão ser objetivos, completos e preservar a confidencialidade das informações.

10. NOTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS INCIDENTES

Os incidentes relacionados a atrasos, falhas de comunicação, ausência de acionamento ou indisponibilidade de recursos deverão ser notificados no sistema institucional, conforme os critérios estabelecidos.

O NSP, em conjunto com os setores envolvidos, deverá avaliar a necessidade de investigação, identificar fatores contribuintes e propor ações corretivas e preventivas.

A análise deverá priorizar eventos com dano grave, eventos sentinela, recorrência de falhas e situações com potencial de comprometer a segurança do paciente.

11. MONITORAMENTO E INDICADORES

O NSP e as lideranças assistenciais deverão acompanhar indicadores para avaliar a efetividade do protocolo.

Indicador	Método de acompanhamento
Tempo entre identificação e acionamento	Horário do acionamento menos horário da identificação
Tempo entre acionamento e avaliação	Horário da avaliação menos horário do acionamento
Conformidade dos registros	Registros completos ÷ registros avaliados × 100
Adesão ao protocolo	Atendimentos conformes ÷ atendimentos avaliados × 100
Incidentes relacionados a atrasos	Quantidade de ocorrências notificadas por período
Adesão às capacitações	Profissionais capacitados ÷ público previsto × 100

As metas e a periodicidade de análise deverão ser definidas pela instituição após avaliação da linha de base e da capacidade assistencial.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este protocolo deverá ser divulgado a todos os profissionais envolvidos na assistência e integrado aos protocolos de emergência, deterioração clínica, parada cardiorrespiratória, transferência de pacientes e segurança do paciente.

Sua implementação depende de aprovação institucional, definição dos contatos e códigos de emergência, estabelecimento de tempos de resposta, capacitação das equipes e disponibilidade dos recursos necessários.

A priorização deverá ser continuamente reavaliada conforme a evolução clínica do paciente, prevalecendo sempre a necessidade de atendimento imediato diante de risco iminente à vida.

Av. João Machado Nº 1234 . Centro
João Pessoa . Paraíba
CEP: 58013 522
T. 83 2107 9500
www.hsvp-iwgp.com.br
iwgp90@hotmail.com

CNPJ: 09124165000140

REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução RDC nº 36, de 25 de julho de 2013.** Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde.

SOCIETY OF CRITICAL CARE MEDICINE. **Diretrizes sobre o reconhecimento e resposta à deterioração clínica fora da UTI: 2023.** Tradução para o português.

ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS. **National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS.** Londres, 2017.

As referências deverão ser conferidas e complementadas conforme as normas vigentes, os protocolos institucionais e a população atendida.

Elaborado por:	Revisado por:	Reconhecido por:
Nayanne Ingrid Farias Mota Guerra Núcleo de Segurança do Paciente / Qualidade	Giulianna Carla Marçal Lourenço Coordenadora de enfermagem	Sonia da Silva Delgado Diretora Assistencial
	Data: 01/10/2026	Data: 01/10/2026